·论著·

基于扎根理论的发热哨点诊室运行评价指标体系构建研究

扫描二维码
查看原文

朱晓燕[1]，黄赟聪[2]，黄倩[3]，顾杰[4]，陈海英[5]，唐岚[3]，王朝昕[1]，黄蛟灵[1,6*]

【摘要】 **背景** 2020年3月，上海市卫生健康委提出在基层医疗卫生机构设置发热哨点诊室，以局部应急处置与常态化疫情防控相结合的原则，应对疫情零星散发。**目的** 探索并构建一套普适、规范的发热哨点诊室运行评价指标体系。**方法** 2021年1—4月，采用目的性抽样法，分别从上海市中心城区、郊区、城郊结合地区选取1家发热哨点诊室，通过实地考察、对来自3家发热哨点诊室的10名工作人员进行两轮半结构化深度访谈，获得原始资料，借助ROST CM6软件整理访谈资料，采用Charmaz建构主义扎根理论的范式分析资料。采用目的抽样法，邀请熟悉发热哨点诊室运行特征的专家（发热哨点诊室管理者、高校研究人员、相关协会学者、卫生发展研究机构人员等）12名作为函询对象，于2021年5—6月采用专家函询法对其进行两轮函询，并运用层次分析法确定各级指标权重、检验各级指标逻辑一致性，最终形成发热哨点诊室运行评价指标体系。**结果** 基于扎根理论构建而成的发热哨点诊室运行评价指标体系由5个一级指标、13个二级指标、29个三级指标组成。两轮专家函询问卷的有效回收率均为100.0%，专家权威系数均为0.81，Kendall's *W* 系数分别为0.265（χ^2=163.768，*P*<0.001）、0.320（χ^2=130.323，*P*<0.001）。最终形成的发热哨点诊室运行评价指标体系由5个一级指标（功能和职责、诊室设置要求、人员配备、工作流程和工作规范）、13个二级指标和25个三级指标构成，5个一级指标的权重分别为0.033 7、0.056 4、0.392 6、0.377 8、0.139 5。各层级指标的一致性比率（*CR*值）为0.056 5、0.032 5、0.042 4（<0.100 0）。**结论** 将扎根理论运用于发热哨点诊室运行评价指标体系的构建具有较强的操作性，构建的评价指标体系具有一定的科学性和应用价值。后续随着政策的迭代，可借助扎根理论对评价指标体系进行进一步补充和完善。

【关键词】 发热哨点诊室；扎根理论；建构主义；评价指标体系；构建；社区卫生服务

【中图分类号】 R 563.12 R 197.1 【文献标识码】 A DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0111

朱晓燕，黄赟聪，黄倩，等. 基于扎根理论的发热哨点诊室运行评价指标体系构建研究［J］. 中国全科医学，2022，25（25）：3143-3149，3156.［www.chinagp.net］

ZHU X Y，HUANG Y C，HUANG Q，et al. The construction of an evaluation index system for operation of fever alertness clinics based on grounded theory［J］. Chinese General Practice，2022，25（25）：3143-3149，3156.

The Construction of an Evaluation Index System for Operation of Fever Alertness Clinics Based on Grounded Theory

ZHU Xiaoyan[1]，*HUANG Yuncong*[2]，*HUANG Qian*[3]，*GU Jie*[4]，*CHEN Haiying*[5]，*TANG Lan*[3]，*WANG Zhaoxin*[1]，*HUANG Jiaoling*[1,6*]

1.School of Public Health，Shanghai Jiao Tong University School of Medicine，Shanghai 200025，China

2.Hongkou District Beiwaitan Community Health Center，Shanghai 200082，China

3.Pudong New Area District Weifang Community Health Center，Shanghai 200122，China

4.Department of General Medicine，Zhongshan Hospital，Fudan University，Shanghai 200032，China

5.Fengxian District Fengpu Community Health Center，Shanghai 201400，China

6.Center for Health Technology Assessment，China Hospital Development Institute，Shanghai Jiao Tong University，Shanghai 200025，China

**Corresponding author：HUANG Jiaoling，Associate professor；E-mail：jiaoling_huang@sina.com*

基金项目：上海市科技创新行动计划软科学重点项目（21692190200，22692192300）；国家自然科学基金资助项目（71904145）；上海交通大学医学院科技创新项目-人文社科类（WK2102）；上海交通大学中国医院发展研究院2022年度医院管理建设项目（CHDI-2022-B-31）；上海市三年公共卫生行动计划（GWV-13）；上海交通大学新进教师启动计划（19X100040062）

1.200025 上海市，上海交通大学医学院公共卫生学院 2.200082 上海市虹口区北外滩街道社区卫生服务中心 3.200122 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 4.200032 上海市，复旦大学附属中山医院全科医学科 5.201400 上海市奉贤区奉浦街道社区卫生服务中心 6.200025 上海市，上海交通大学中国医院发展研究院卫生技术评估研究所

*通信作者：黄蛟灵，副研究员；E-mail：jiaoling_huang@sina.com

本文数字出版日期：2022-07-15

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

【Abstract】 **Background** In March 2020, the Shanghai Municipal Health Commission proposed that fever alertness clinics should be set up in primary healthcare institutions (community health service centers) to deal with multi-site sporadic outbreaks by the principle of local emergency disposal combined with standardized and regular outbreak control. **Objective** To explore and construct a comprehensive and standardized evaluation index system for the operation of fever alertness clinics. **Methods** Two rounds of semi-structured in-depth interviews were conducted with 10 staff from three fever alertness clinics in downtown, suburban, and peri urban locations of Shanghai, respectively, using a purposive sampling method from January to April 2021. Raw data were obtained, interview materials were collated with the aid of the ROST CM6 software, and paradigm analyses were conducted using the Charmaz constructing grounded theory. Using a purposive sampling method, 12 experts familiar with the operating characteristics of fever alertness clinics (fever alertness clinics managers, researchers from universities, scholars from related associations, health development institutes, etc.) were invited as consulting objects to answer the correspondence questionnaire for 2 rounds from May to June 2021, and the weighting of indicators at each level was determined by hierarchical analysis to check the logical consistency of indicators at all levels, the evaluation index system of operation of fever alertness clinics was finally formed. **Results** The evaluation index system for operation of fever alertness clinics, which was constructed based on the grounded theory, consisted of 5 primary indicators, 13 secondary indicators and 29 tertiary indicators. The effective recoveries rate of the two rounds of expert consultation questionnaires was 100.0%, the expert authority coefficient of the two rounds was all 0.81, Kendall's *W* coefficients were 0.265 (χ^2=163.768, P<0.001) and 0.320 (χ^2=130.323, P<0.001), respectively. The final developed evaluation index system for operation of fever alertness clinics consisted of 5 primary indexes (functions and responsibilities, consulting room setting requirements, staffing, workflow and work specifications), 13 secondary indexes and 25 tertiary indexes. The weights of the five primary indexes were 0.033 7, 0.056 4, 0.392 6, 0.377 8 and 0.139 5, respectively. The consistency ratio (*CR*) of indicators at all levels was 0.056 5、0.032 5、0.042 4 (<0.100 0). **Conclusion** The application of grounded theory to the construction of evaluation index system for fever alertness clinics is highly operable, and the constructed evaluation index system has a certain scientific validity and application value. Follow up with the policy iterations, the evaluation index system can be further supplemented and improved with the aid of grounded theory.

【Key words】 Fever alertness clinics; Grounded theory; Constructivism; Evaluation index system; Construction; Community health services

2020-03-22，上海市卫生健康委提出，在全市已有117家发热门诊的基础上，增加建设182家社区卫生服务中心发热哨点诊室，以进一步加强发热患者筛查、登记和随访工作，减轻综合医院发热门诊的负担，充分发挥发热哨点诊室在疫情防控中的“哨兵”作用[1]。随着上海市社区卫生服务中心发热哨点诊室建设工作的深入开展，四川省、山东省、浙江省、广西壮族自治区、河南省、北京市等省份亦着手组织开展发热哨点诊室建设工作[2]。目前，国内尚未建立健全发热哨点诊室运行评价指标体系，对于发热哨点诊室的运行质量缺乏统一的考核、评价标准。发热哨点诊室运行评价指标体系的构建有助于保障发热哨点诊室安全、稳定运行，同时也是促进发热哨点诊室充分发挥职能的有力“抓手”。本研究采用扎根理论研究方法，直接从实际观察入手，从原始资料中归纳经验概括，从而初步确立各级发热哨点诊室运行评价指标。在此基础上，通过专家函询法遴选评价指标，借由层析分析法确定各级指标权重、检验各级指标逻辑一致性，最终构建了一套发热哨点诊室运行评价指标体系，旨在为基层卫生政策的制定、发热哨点诊室运行效果的客观评价、发热哨点诊室服务水平的提升奠定一定的基础[3-5]。

1 对象与方法

1.1 基于扎根理论初步构建发热哨点诊室运行评价指标体系

1.1.1 研究对象 考虑到上海市中心城区、郊区、城郊结合地区发热哨点诊室在覆盖的人口数、目标定位、功能划分等方面存在差异，本研究分别从上海市中心城区、郊区、城郊结合地区选取1家发热哨点诊室作为样本来源地。于2021年1—4月，采用目的性抽样法，选取来自上述3家发热哨点诊室且参与发热哨点诊室运行的工作人员作为研究对象。纳入标准：（1）具有丰富接诊经验的一线医务人员或发热哨点诊室运行管理人员;（2）熟练掌握新型冠状病毒肺炎的诊断标准、治疗原则、防护标准等；（3）知情同意，并自愿参加本次研究。样本量的确定以理论饱和为标准，即访谈对象所提供的资料不能进一步揭示类属的属性和维度、无法产生新的理论见解时，停止抽样。

1.1.2 研究方法

1.1.2.1 方法学的确立 本研究采用建构主义扎根理论的范式收集和分析资料[6]。建构主义扎根理论认为，现实是一种相对主义的现实，是在特定的社会和情境中建构的，而建构过程取决于研究者与受访者间的互动。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同时建构主义扎根理论强调研究者所建构的现实并非现实的形象，而是一种形象的现实[6-7]。本研究试图构建的发热哨点诊室运行评价指标体系是研究者与受访者在特定的历史、社会发展情景下所展示的暂时的现实，并且也是对研究者与受访者共同建构的意义的一种诠释，因此选择建构主义研究范式。

1.1.2.2 访谈资料收集 通过回顾国内外文献编写访谈提纲，邀请领域专家对访谈提纲进行审阅并提出建议或意见。针对管理人员的访谈内容主要涉及制度与组织、硬件设施建设、人力资源配置（数量+能力）、工作流程等方面；针对医务人员的访谈内容主要涉及工作内容、协同分工、安全防护、支持与薪酬、面临的困难与建议等方面。访谈前，研究人员与受访者约定访谈时间。在正式访谈前2 d，研究人员将访谈提纲发送给受访者，并通过选择访谈对象熟悉的环境、提前了解访谈对象的背景等方式方法，消除与访谈对象间的疏离感。为避免理解性偏差，每场访谈均由两名研究人员（1名研究生、1名带队老师）负责。按照约定的时间，研究人员与受访者在安静、独立的环境中（发热哨点诊室所在的社区卫生服务中心）进行两轮“面对面”的半结构化深度访谈。两轮访谈的时间间隔为3~7 d，第2轮访谈内容是对第1轮访谈内容的有效补充与完善，合计访谈时间为1.5~2.0 h。访谈开始前，研究人员向受访者说明本研究的目的、意义，告知受访者访谈内容将完全保密、需录音留存，并征得其明确同意。访谈过程中，研究人员根据访谈提纲指引和受访者实际情况，对提问顺序和方式做灵活调整，对有价值的问题进行适当追问。同时对受访者的任何语言予以尊重、不加评判，不对其施加任何诱导或干预。为保护受访者隐私，受访者的姓名均以编号代替。文本转录完成后，将文本发送给受访者，以求证文字资料的准确性和完整性。每轮访谈结束后，针对访谈和转录过程中出现的看法、困惑和偏差进行反省和记录，从而保证研究的质量。

1.1.2.3 资料分析方法 于访谈结束2周内，由访谈人员反复听录音，并将录音逐字转录为文本资料。剔除与研究主题无关的文本内容后，对文本逐字、逐句进行分解。运用ROST CM6对文本进行词频分析。遵循建构主义扎根理论的研究方法分析资料。（1）开放式编码：对原始文本进行逐字、逐句的编码，并对出现频次较高的、与发热哨点诊室运行评价指标相关的语句进行“贴标签”处理，以从原始资料中归纳经验概括，总结概念及其范畴。开放式编码遵循开放和忠于文本的原则，编码过程中研究者尽量通过受访者的原话来挖掘“标签”的初始概念及其范畴。（2）关联式编码：针对开放式编码结果，在反复思考的基础上，发现和建立各个初始范畴之间的关联。在此过程中，主要通过聚类分析法将相似的初始范畴聚集到同一个“类簇”中，进而逐步确立范畴之间的类属关系。（3）选择性编码：系统处理各个范畴之间的关系，找出核心范畴，把其系统地和其他范畴联系起来。（4）理论饱和度检验：当访谈对象所提供的资料不能进一步揭示类属的属性和维度、无法产生新的理论见解时，以预留的2份文本数据和一系列有关发热哨点诊室建设及运行的政策文件进行理论饱和度的检验。

1.2 发热哨点诊室运行评价指标体系的专家函询

1.2.1 拟定专家函询问卷 在基于扎根理论初步构建发热哨点诊室运行评价指标的基础上，对整理出的指标进行分析和讨论，最终拟定专家函询问卷。专家函询问卷内容如下：（1）卷首语，向专家介绍研究的内容和目的，以及问卷的填写方法。（2）专家基本信息调查表，调查内容包括性别、年龄、最高学历、专业技术职称、职业（务）、专业领域、专业工作年限等。（3）发热哨点诊室运行评价指标咨询表，各级指标的重要性采用Likert 5级评分法，从“很不重要”~“很重要”分别计1~5分。每一个条目下方都设有开放式的“专家意见栏”，请专家在意见栏中阐述其对评价指标的不同看法和修改意见。（4）专家对指标的熟悉程度与判断依据评分。专家的熟悉程度分为很熟悉、熟悉、较熟悉、一般、较不熟悉、很不熟悉6个等级，分别计1.0、0.8、0.6、0.4、0.2、0；专家的判断依据包括4个方面，判断依据的影响程度分为大、中、小3个等级，分别赋予不同的量化值，即理论分析赋值0.1、0.2、0.3，工作经验赋值0.5、0.4、0.3，国内外相关文献赋值0.1、0.1、0.1，直观感觉赋值0.1、0.1、0.1。本咨询问卷的Cronbachs′ α 系数为0.830。

1.2.2 遴选咨询专家 采用目的抽样法，邀请熟悉发热哨点诊室运行特征的专家作为函询对象，函询专家不仅包括发热哨点诊室管理者，还包括高校研究人员、相关协会学者、卫生发展研究机构人员等。遴选标准：（1）专业领域为卫生政策与管理/医疗保障/全科医学，熟悉基层医疗卫生机构发热哨点诊室建设和运行工作；（2）从事相关领域工作≥5年；（3）具有本科及以上学历、中级及以上专业技术职称。

1.2.3 专家函询及指标筛选 2021年5—6月，采用专家函询法进行两轮专家函询。通过线上方式（微信、电子邮件等）发放调查问卷。于2021年5月发放第1轮问卷。问卷收回后，根据专家的意见，计算各项指标条目专家评分的重要性赋值均数、满分比、变异系数（*CV*）。采用界值法筛选指标，以重要性赋值均数≥3.50分、满分比≥20%、*CV*≤0.20作为界值；对于以上3个衡量尺度均不合格的指标予以剔除，对于有1个或2个尺度不合格的指标，结合专家意见进行调整。在进行第2轮咨询时，将上一轮的咨询结果及指标修改意见反馈给专家，同时邀请专家对修改后的指标体系进行重新评分。以专家意见趋于统一作为指标筛选完成的判断依据。两

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

轮问卷均于1个月内完成发放和回收，相邻2轮问卷发放的时间间隔为1个月。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.0软件进行数据录入和统计分析。正态分布的计量资料采用（$\bar{x} \pm s$）表示，计数资料采用相对数表示。专家的积极系数通过有效问卷回收率来反映。判断依据由判断系数表示，各判断依据（理论分析、工作经验、国内外相关文献和直观感觉）影响程度赋分相加即为该名专家的判断系数。熟悉程度由熟悉系数表示。专家的权威程度由权威系数来表示，权威系数=（熟悉系数+判断系数）/2。权威系数≥0.7，即可认为研究结果较为可靠。专家意见的集中程度采用指标的重要性赋值均数和标准差来表示；专家意见的离散程度通过*CV*表示[8]。专家意见的协调程度用Kendall's *W*系数来表示，Kendall's *W*系数越大说明专家的协调程度越高[9-10]。通过运用yaahp构造层次模型。采用层次分析法确定各级指标权重、检验各级指标逻辑一致性，各层级指标的一致性比率（*CR*值）<0.100 0时，说明判断矩阵的一致性可以接受。以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基于扎根理论的发热哨点诊室运行评价指标体系初步构建结果

2.1.1 访谈对象一般资料 共纳入访谈对象10名。其中男3名，女7名；年龄33~50岁，平均年龄（40.3±5.2）岁；8名学历为本科；8名社区工作年限≥5年。受访者的基本情况见表1。

2.1.2 开放式编码结果 经过多次的比较、合并，剔除出现频次<2次的初始概念，最终共抽象出36个初始概念，形成了23个初始范畴。初始范畴及与其相对应的初始概念见表2。

表1 受访者基本情况

Table 1 General information of interviewees

编号	性别	年龄（岁）	学历	职务	社区工作年限（年）
1[a]	男	35	本科	医师	4
2[a]	男	42	本科	医师	5
3[a]	女	33	本科	护士	4
4[a]	女	41	本科	护士长	5
5[a]	女	43	大专	护士长	6
6	男	50	本科	社区卫生服务中心副主任（全面负责发热哨点诊室日常运行工作）	12
7	女	36	本科	医务科长（负责发热哨点诊室日常诊疗管理工作，以及人员协调与工作安排）	5
8	女	36	本科	总护士长（负责发热哨点诊室院感防控、消毒、医疗废物管理工作）	7
9	女	43	本科	医教科长（负责联系上级卫生部门，配合完成发热患者转运工作）	10
10	女	44	大专	社区卫生服务中心副主任（全面负责发热哨点诊室日常运行工作）	12

注：[a]表示按照针对医务人员拟定的访谈提纲对其进行访谈

2.1.3 关联式编码结果 将开放式编码阶段获得的23个初始范畴（对“人员配备”“功能与职责”两大初始范畴及与其相对应的初始概念进行细化后，初始范畴数增至29个）进行关联式编码，共得到13个附属范畴，见表3。

2.1.4 选择性编码结果 本研究的核心范畴是“发热哨点诊室运行评价指标体系构建”，围绕此核心范畴，深入分析关联式编码阶段所产生的13个附属范畴，发现功能和职责、诊室设置要求、人员配备、工作流程和工作规范是构成发热哨点诊室运行评价指标体系的五大元素，见表3。

2.1.5 理论饱和度检验结果 结果显示：未发现新的初始范畴和初始概念，发热哨点诊室运行评价指标体系已初步构建完备。初步构建的发热哨点诊室运行评价指标体系由5个一级指标、13个二级指标、29个三级指标组成，见表3。

2.2 发热哨点诊室运行评价指标体系的专家函询结果

2.2.1 函询专家的基本情况 12名专家中，女8名（66.7%）；年龄为30~45岁者6名（50.0%），>45~60岁者6名（50.0%）；8名（66.7%）最高学历为研究生（其中5名为博士研究生，3名为硕士研究生）；12名专家均具有中级及以上专业技术职称；6名（50.0%）为发热哨点诊室管理者，5名为（41.7%）高校教师；7名（58.3%）专业领域为卫生政策与管理；7名（58.3%）专业工作年限>15年。函询专家基本情况具体见表4。

2.2.2 专家的积极系数 第1轮专家函询发放问卷12份，回收有效问卷12份，有效问卷回收率为100.0%；第2轮专家函询发放问卷12份，回收有效问卷12份，有效问卷回收率为100.0%。

2.2.3 专家的权威程度和协调程度 两轮专家函询专家的判断依据为0.88、熟悉程度为0.75、权威系数为0.81。第1、2轮专家函询的Kendall's *W*系数分别为0.265（$\chi^2=163.768$，$P<0.001$）、0.320（$\chi^2=130.323$，$P<0.001$）。

2.2.4 指标筛选过程

2.2.4.1 第1轮专家函询结果 一级指标的重要性赋值均数为4.67~4.92分，*CV*为0.06~0.14；二级指标的重要性赋值均数为4.33~4.83分，*CV*为0.08~0.15；三级指标的重要性赋值均数为4.15~4.89分，*CV*为0.09~0.22。9名专家针对8项指标给出了11条修订意见。根据指标筛选标准、专家函询及研究小组讨论结果，对指标进行补充、删减和修改。（1）删除三级指标5个：转运流程、跟踪与随访、宣传栏、功能与任务执行、主动引导就诊。（2）修改三级指标2个：将“人员配备”修改为“联合团队人员配备”，将“流行病学调查”修改为“发热患者筛查”。（3）新增1个3级指标：发热

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 开放式编码范畴化

Table 2 Open coding categorization

编号	初始范畴	代表性的原始语句（初始概念）
1	发热患者跟踪管理	采用公安系统提供的身份识别系统精准开展信息登记工作（身份识别验证系统）
2	主动引导就诊	预约就诊是疫情防控期间比较合适的方式（预约平台引导）
		诊室内安置了电子屏幕，用于滚动播放宣教内容（健康宣教引导）
3	流行病学调查	候诊区护士兼任预检和流行病学史调查工作（外出史、接触史、活动轨迹、潜伏期的评估）
4	闭环管理	通过严格执行“筛查—报告—转运”流程，打造发热哨点诊室与发热门诊之间的闭环（及时隔离与点对点的转运工作）
5	医护人员资质	我中心由 2 名接受过传染病知识培训的高年资全科主治医师承担发热哨点诊室工作（症状鉴别诊断）
6	成立质控管理小组	按照市卫健委文件要求，发热哨点诊室要成立相关的工作小组，还要明确各部门分工（成立质控小组）
7	完整的会诊模式	转诊之前，医联体专家与发热哨点诊室医生、内部专家组实时连线，对患者进行远程会诊（远程会诊）
8	监督与培训	发热哨点诊室学习及培训制度（培训制度）
		消毒隔离操作及诊疗规范的培训（规范化培训）
		接受过培训的全科医生轮流坐诊（规范化培训）
		除了接受来自市、区卫生监督部门的督导，医务科、护理部要定期对发热哨点诊室进行督导检查（卫生部门督导）
9	转诊流程	转诊工作由卫健委统筹协调（负责转诊调度的机构）
		医联体单位通知转诊之前，我们会告知发热患者，建议他做个核酸、做个 CT（转诊前患者隔离与转诊告知）
		护士预检—流行病学史调查—医生检查复核—转诊（转诊流程与规范）
10	信息登记与检测	采用公安系统提供的身份识别系统精准开展信息登记工作（信息准确性）
		我们诊室有 4 本登记本，对发热患者及时进行网络直报（及时网络直报）
11	诊室规范化设置	我们中心按照市卫健委的文件要求，根据房屋的实际使用情况，建成位置、面积、设备、人员、防护、运行和管理均符合要求的发热哨点诊室；尽量使诊室符合“三区两通道”要求（位置、面积、设备、人员、防护、运行）
12	基本设施设置	诊疗台、诊疗椅、电脑、打印机等办公室设备，一次性压舌板等诊疗检查设备，以及医疗废弃物桶、快速手消毒设施等（基本设施配置）
13	人员配备	按照市卫健委文件要求，发热哨点诊室成立了工作小组（行政管理人员）
		我们对全科医生和专职护士进行了培训，采用全科医生轮流坐诊制，开展医联体内专家线上会诊（医护人员、联合团队、线上会诊）
14	就诊流程	制定与落实发热患者就诊制度及流程，并让流程上墙（就诊流程规范化）
15	随访	对转诊的发热患者也会进行随访，多采取电话随访的形式，询问患者及其家人目前的健康状况（转运后随访）
		对于病因明确的发热患者，向其发放告知书，并定期对其进行电话随访（未转运患者的随访）
		发热哨点诊室的专职护士会定期对病因明确的发热患者进行随访（随访）
16	健康宣教	诊室内安置了电子屏幕，用于滚动播放疾病健康宣教内容（疫情防控宣传）
		通过家庭医生团队向社区居民宣传介绍发热哨点诊室的功能定位及运行方式（信息互动和宣教）
17	防护用品储备	上级卫生部门要求社区卫生服务中心储备 3~4 个月的疫情防控物资，我们发热哨点诊室所要消耗的疫情防控物资也包含在其中（应急物资储备充分）
18	诊室隔离与消毒	在等待转运期间，患者转移至隔离区内休息等候（独立的负压隔离区域）；待患者转运后，发热哨点诊室专业人员将对诊室进行终末消毒（院感防控规范）
19	功能与职责	发热哨点诊室现在主要负责对前来就诊的患者进行排查、登记、管理、流调、隔离、转诊、随访、跟踪管理等（发热哨点诊室的功能和职责）
20	标志标识	上海市统一制定和设计了“发热哨点诊室”的标识牌，专门用于引导发热患者抵达发热哨点诊室（统一标识牌）
21	处置方式	对于病因明确的发热患者，我们会安排其进入全科门诊接受后续治疗（对病因明确发热患者的处理）
		对于需要接受进一步诊断的疑似患者，则会对其进行转诊（对不明原因发热患者的处理）
		将发热患者转诊至发热门诊后，发热哨点诊室与门诊保持信息联动（信息联动）
22	医务人员防护	目前发热哨点诊室的医务人员采用的是二级防护措施：穿隔离服、防护鞋套，戴护目镜、N95 口罩、乳胶手套、防护面罩等（二级防护措施）
23	管理制度	制定发热哨点诊室工作制度、就诊流程、岗位职责、消毒隔离制度、医务人员工作守则等，并让其统一上墙（诊室管理相关制度）

患者转诊。

2.2.4.2 第 2 轮专家函询结果 一级指标的重要性赋值均数为 4.67~4.92 分，*CV* 为 0.06~0.14；二级指标的重要性赋值均数为 4.33~4.83 分，*CV* 为 0.08~0.15；三级指标的重要性赋值均数为 4.25~4.92 分，*CV* 为 0.06~0.19。第 2 轮专家函询中，没有专家提出意见。

2.3 确立发热哨点诊室运行评价指标体系 经过两轮专家函询，最终构建了发热哨点诊室运行评价指标体系。该评价指标体系由 5 个一级指标、13 个二级指标及 25 个三级指标构成。5 个一级指标分别为“功能和职责”“诊室设置要求”“人员配备”“工作流程”“工作规范”，其权重依次为 0.033 7、0.056 4、0.392 6、0.377 8、0.139 5。通过层次分析法计算各层级指标权重及组合权重，各层级指标的 *CR* 值分别为 0.056 5、0.032 5、0.042 4，均

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

CGP Chinese General Practice
September 2022, Vol.25 No.25

表 3 关联式编码形成的范畴关系

Table 3 Categorical relationships formed by associative coding

主范畴	附属范畴	初始范畴
功能和职责	诊室功能	流行病学调查
		主动引导就诊
		发热患者跟踪管理
	诊室职责	预检分诊
		诊断上报
		转运流程
		跟踪与随访
		转运和随访
		功能与任务执行
诊室设置要求	房屋要求	诊室规范化设置
	设施设备	基本设施设置
		宣传栏
		防护用品储备
	标志标识	标志标识导引
人员配备	医护人员	医护人员资质
	行政人员	成立质控管理小组
	联合团队	人员配备
		完整的会诊模式
工作流程	预检分诊	就诊流程
	接诊与处置	健康宣教
		随访管理
		处置方式
		转诊流程
工作规范	接诊工作规范	信息登记与检测
	防护规范	医务人员防护
	管理规范	闭环管理
		培训与监督
		隔离与消毒
		管理制度

<0.100 0，说明指标权重设置合理，见表 5。

3 讨论

3.1 构建发热哨点诊室运行评价指标体系的必要性和实用性 新型冠状病毒肺炎疫情发生后，上海市在全国范围内率先探索建设发热哨点诊室，旨在充分发挥社区卫生服务中心在新型冠状病毒肺炎疫情防控中的“网底”“第一道防线”作用，尽早落实“四早”原则，即早发现、早报告、早隔离、早治疗[5]。随后全国范围内基层医疗卫生机构学习借鉴上海经验和做法，着手建设和改造基层发热哨点诊室[2]。作为新型冠状病毒肺炎疫情防控期间的产物，发热哨点诊室的建设与改造，以及组织架构、管理团队及运行流程的打造等尚无成熟经验可供借鉴。2003 年严重急性呼吸综合征疫情过后，全国各二、三级医院纷纷设立的发热门诊为发热哨点诊室的建设和运行提供了有益的借鉴和启示，但由于两者发挥的功能、覆盖范围不同，发热门诊运作模式对发热哨点诊室的适用性较弱[11]。目前，尚缺乏应用于发热哨点诊室运行情况评价的指标体系，且国内有关发热哨点诊室建设与运行方面的文献报道较少，在此种情况下，运用扎根理论的研究方法探索发热哨点诊室运行评价指标能够很好地解决以上问题[12-13]。

表 4 两轮专家函询的专家基本情况

Table 4 Basic information of experts attending a two-round Delphi survey

项目	例数	占比（%）
性别		
男	4	33.3
女	8	66.7
年龄（岁）		
30~45	6	50.0
>45~60	6	50.0
最高学历		
本科	4	33.3
硕士研究生	3	25.0
博士研究生	5	41.7
职业（务）		
高校教师	5	41.7
发热哨点诊室管理者	6	50.0
卫生发展研究机构人员	1	8.3
专业领域		
卫生政策与管理	7	58.3
医疗保障	2	16.7
全科医学	3	25.0
专业工作年限（年）		
5~10	3	25.0
>10~15	2	16.7
>15	7	58.3

3.2 发热哨点诊室运行评价指标体系的可靠性 本研究采用扎根理论研究方法初步构建发热哨点诊室评价指标，在此基础上，运用专家咨询法对指标进行遴选，并利用层次分析法确定各级指标权重、检验各级指标逻辑一致性。将定性研究方法与定量研究方法相结合，有助于提升评价指标体系的可量化性、可测性和客观性[14-15]。12 名函询专家在卫生政策与管理 / 医疗保障 / 全科医学领域均具有≥ 5 年的工作经验，积累了丰富的基层疫情防控相关理论知识和实践经验，可靠性相对较高。两轮专家函询问卷的有效回收率均为 100.0%，专家权威系数均 >0.70，提示专家的积极程度和权威性均较高。第 2 轮专家函询的 Kendall′s W 系数为 0.320（P<0.001），说明专家协调程度良好。通过对专家意见进行分析和整理，并结合专家意见对评价指标进行调整和完善，最终形成了具有共识性的研究成果[16]。本研究发现，将扎根理论运用于（发热哨点诊室运行）评价指标体系的构建具有较强的操作性、可行性，本研究在一定程度上推动了扎根理论研究方法在评价指标体系构建领域的应用[17]。

3.3 发热哨点诊室运行评价指标体系的科学性和合理性 数据显示，截至 2020 年底，上海市社区发热哨点诊室累计接诊超过 2.5 万人次。国家卫生健康委基层卫

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表5 发热哨点诊室运行评价指标体系及权重结果

Table 5 Evaluation index system for operation of fever alertness clinics and weights assigned to its indicators

指标	重要性赋值（$\bar{x}\pm s$，分）	变异系数	权重
功能和职责	4.67 ± 0.65	0.14	0.033 7
诊室功能	4.58 ± 0.52	0.11	0.016 9
发热患者筛查	4.50 ± 0.67	0.15	0.005 8
发热患者转诊	4.67 ± 0.89	0.19	0.001 2
发热患者跟踪管理	4.25 ± 0.72	0.17	0.003 1
诊室职责	4.53 ± 0.64	0.14	0.016 9
预检分诊	4.67 ± 0.89	0.19	0.010 2
诊断上报	4.20 ± 0.78	0.19	0.011 2
转运和随访	4.33 ± 0.62	0.14	0.002 4
诊室设置要求	4.75 ± 0.45	0.09	0.056 4
房屋要求	4.42 ± 0.67	0.15	0.003 9
诊室规范化设置	4.50 ± 0.67	0.15	0.002 9
设施设备	4.67 ± 0.65	0.14	0.043 7
基本设施设置	4.50 ± 0.67	0.15	0.002 9
防护用品储备	4.92 ± 0.29	0.06	0.044 5
标志标识	4.58 ± 0.52	0.11	0.008 7
标志标识导引	4.50 ± 0.67	0.15	0.006 1
人员配备	4.92 ± 0.29	0.06	0.392 6
医护人员	4.83 ± 0.39	0.08	0.254 6
医护人员资质	4.58 ± 0.52	0.11	0.225 4
行政人员	4.33 ± 0.65	0.15	0.022 3
成立质控管理小组	4.25 ± 0.75	0.18	0.019 6
联合团队	4.33 ± 0.65	0.15	0.115 7
联合团队人员配备	4.42 ± 0.79	0.18	0.034 1
完整的会诊模式	4.50 ± 0.80	0.18	0.113 4
工作流程	4.92 ± 0.29	0.06	0.377 8
预检分诊	4.58 ± 0.67	0.15	0.054 0
就诊流程	4.42 ± 0.79	0.18	0.010 4
接诊与处置	4.83 ± 0.39	0.08	0.323 8
健康宣教	4.50 ± 0.80	0.18	0.066 4
随访管理	4.75 ± 0.62	0.13	0.100 3
处置方式	4.75 ± 0.62	0.13	0.100 3
转诊流程	4.75 ± 0.62	0.13	0.100 3
工作规范	4.83 ± 0.39	0.08	0.139 5
接诊工作规范	4.75 ± 0.45	0.09	0.046 5
信息登记与检测	4.67 ± 0.49	0.10	0.010 7
防护规范	4.75 ± 0.45	0.09	0.046 5
医务人员防护	4.75 ± 0.45	0.09	0.032 2
管理规范	4.75 ± 0.45	0.09	0.046 5
闭环管理	4.75 ± 0.45	0.09	0.022 1
培训与监督	4.75 ± 0.45	0.09	0.030 3
隔离与消毒	4.75 ± 0.45	0.09	0.022 1
管理制度	4.75 ± 0.45	0.09	0.022 1

生健康司充分肯定上海首创做法，推广分享上海经验[2]。随后，北京市、四川省、湖北省、河南省、广西壮族自治区等省份针对发热哨点诊室的建设与运行开始了积极探索实践。丰富实践为理论创新奠定了坚实基础、提供了有力保障。5个一级指标中，权重排在前三位的一级指标依次为“人员配备（0.392 6）”“工作流程（0.377 8）”“工作规范（0.139 5）”，这一结果与政策文本对发热哨点诊室运行和设置提出的要求高度契合，一定程度上表明本研究构建的发热哨点诊室运行评价指标体系具有一定的科学性和合理性[18]。本研究发现，功能和职责、诊室设置要求、人员配备、工作流程和工作规范是构成发热哨点诊室运行评价指标体系的五大元素，该结果不仅能为其他地区发热哨点诊室的建设和改造工作提供方向性借鉴，还可为上海市发热哨点诊室运行评价提供“准绳”与“量尺”[19]。政策是在一定时间内的历史条件下推行的现实政策，具有明确的时效性。考虑到发热哨点诊室是新型冠状病毒肺炎疫情防控期间的产物，随着各地进入常态化疫情防控阶段，政策也会处于不断变化及更新的状态，运用扎根理论构建的发热哨点诊室运行评价指标体系可随着政策的迭代不断得到推进、发展和完善[19]。

3.4 本研究的局限性 本研究探讨了发热哨点诊室运行评价的指标要素，在无先例可循的情况下，研究者通过深入体验、深度观察、对发热哨点诊室工作人员进行深度访谈，从获得的原始资料中归纳经验概括，然后上升到理论[14]。但是，本研究仍处于理论研究阶段。考虑到不同地区发热哨点诊室建设水平存在较大差距，该指标体系在不同地区的可操作性、可应用程度仍有待进一步研究。不同地区学者可对其不断进行修正和完善，以增强其本土适用性。此外，发热哨点诊室作为基层疫情防控的“哨点”和“网底”，其“低门槛、广覆盖”的特点也决定了不能采用经济效益指标来评价其运行效果。发热哨点诊室具有“非排他性”和“非竞争性”，其数量的多寡和质量的高低在某种程度上体现了地区公共福利事业的发展水平，故本研究构建的发热哨点诊室运行评价指标体系未涉及“结果面”指标，如接诊人次、转诊人次、出院率等。

作者贡献：黄蛟灵负责文章的构思和设计、研究的实施与可行性分析，并对文章整体负责；朱晓燕负责论文撰写；黄贇聪、黄倩、顾杰、陈海英、唐岚负责数据的收集和整理；王朝昕负责论文的修订。

本文无利益冲突。

参考文献

[1] 上海市卫生健康委员会. 上海在117家发热门诊基础上，增建182家发热哨点诊室[EB/OL].（2020-03-22）[2021-06-10]. http://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20200322/7c1d31fdc8854fd5a56558370fa683d0.html.

[2] 国家卫生健康委员会医政医管局. 关于推广上海市发热门诊建设管理工作经验的通知[A/OL].（2020-05-12）[2021-06-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202005/5795a20588fc45d2874d1781ed7aad4b.shtml.

[3] FOLEY G，TIMONEN V. Using grounded theory method to capture and analyze health care experiences[J]. Health Serv Res，2015，50（4）：1195-1210. DOI：10.1111/1475-6773.12275.

[4] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京：教育科学出版社，2000.

（下转第3156页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

constipation: longitudinal follow-up beyond puberty [J]. Gastroenterology, 2003, 125(2): 357-363. DOI: 10.1016/s0016-5085(03)00888-6.

[20] RAJINDRAJITH S, DEVANARAYANA N M, BENNINGA M A. Children and adolescents with chronic constipation: how many seek healthcare and what determines it[J]. J Trop Pediatr, 2012, 58(4): 280-285. DOI: 10.1093/tropej/fmr096.

[21] CHMIELEWSKA A, HORVATH A, DZIECHCIARZ P, et al. Glucomannan is not effective for the treatment of functional constipation in children: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial [J]. Clin Nutr, 2011, 30(4): 462-468. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.01.012.

[22] LOENING-BAUCKE V. Prevalence, symptoms and outcome of constipation in infants and toddlers[J]. J Pediatr, 2005, 146(3): 359-363. DOI: 10.1016/j.jpeds.2004.10.046.

[23] BOROWITZ S M, COX D J, TAM A, et al. Precipitants of constipation during early childhood [J]. J Am Board Fam Pract, 2003, 16(3): 213-218.

[24] XINIAS I, MAVROUDI A. Constipation in childhood. An update on evaluation and management [J]. Hippokratia, 2015, 19(1): 11-19.

[25] LIEM O, HARMAN J, BENNINGA M, et al. Health utilization and cost impact of childhood constipation in the United States [J]. J Pediatr, 2009, 154(2): 258-262.

[26] LOENING-BAUCKE V. Controversies in the management of chronic constipation[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2001, 32(suppl 1): s38-39. DOI: 10.1097/00005176-200104001-00017.

[27] TRIVI I, HOJSAK I. Initial diagnosis of functional gastrointestinal disorders in children increases a chance for resolution of symptoms[J]. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr, 2018, 21(4): 264-270. DOI: 10.5223/pghn.2018.21.4.264.

[28] VAN DEN BERG M M, BENNINGA M A, DI LORENZO C. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review [J]. Am J Gastroenterol, 2006, 101(10): 2401-2409. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00771.x.

[29] TAMURA A, TOMITA T, OSHIMA T, et al. Prevalence and self-recognition of chronic constipation: results of an internet survey [J]. J Neurogastroenterol Motil, 2016, 22(4): 677-685. DOI: 10.5056/jnm15187.

[30] RUSSO M, MARTINELLI M, SCIORIO E, et al. Stool consistency, but not frequency, correlates with total gastrointestinal transit time in children [J]. J Pediatr, 2013, 162(6): 1188-1192. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.11.082.

[31] FREEMAN K A, RILEY A, DUKE D C, et al. Systematic review and meta-analysis of behavioral interventions for fecal incontinence with constipation [J]. J Pediatr Psychol, 2014, 39(8): 887-902. DOI: 10.1093/jpepsy/jsu039.

[32] MICHEL R S. Toilet training [J]. Pediatric Rev, 1999, 20(7): 240.

[33] BLUM N J, TAUBMAN B, NEMETH N. Relationship between age at initiation of toilet training and duration of training: a prospective study [J]. Pediatrics, 2003, 111(4 pt 1): 810-814. DOI: 10.1542/peds.111.4.810.

[34] BLUM N J, TAUBMAN B, NEMETH N. During toilet training, constipation occurs before stool toileting refusal [J]. Pediatrics, 2004, 113(6): e520-522. DOI: 10.1542/peds.113.6.e520.

（收稿日期：2022-02-23；修回日期：2022-07-08）
（本文编辑：王凤微）

（上接第3149页）

[5] HASSON F, KEENEY S, MCKENNA H. Research guidelines for the Delphi survey technique [J]. J Adv Nurs, 2000, 32(4): 1008-1015.

[6] CHARMAZ K. Constructing grounded theory [M]. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014: 113, 120, 138, 150, 213.

[7] JANE M, ANN B, KAREN F. The development of constructivist grounded theory [J]. Int J Qual Meth, 2006, 5(1): 1-10.

[8] 任依，刘艳丽，马力. 基层医疗卫生机构设置发热哨点诊室的建议与思考[J]. 中国全科医学，2021，24(10)：1183-1189. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.104.

[9] 王蒙杰，刘德明，杨非，等. 应用德尔菲法和层次分析法构建四川省核应急医学资源配置指标体系[J]. 中国辐射卫生，2017，26(5)：562-567，579.

[10] 何宇，杨小丽. 基于德尔菲法的精神卫生服务可及性评价指标体系研究[J]. 中国全科医学，2018，21(3)：322-329. DOI：10.3969/j.issn.1007-9572.2017.00.091.

[11] 应争先. 让发热门诊成为真正的哨点[N]. 健康报，2020-12-04(003).

[12] 费小冬. 扎根理论研究方法论：要素、研究程序和评判标准[J]. 公共行政评论，2008，1(3)：23-43，197. DOI：10.3969/j.issn.1674-2486.2008.03.003.

[13] 陈新月，尤莉莉，连隽，等. 基于扎根理论的基本公共卫生服务提供质量的影响因素分析[J]. 医学与社会，2021，34(7)：20-24. DOI：10.13723/j.yxysh.2021.07.005.

[14] HARRIS T. Grounded theory [J]. Nurs Stand, 2015, 29(35): 32-39. DOI: 10.7748/ns.29.35.32.e9568.

[15] SHEN L, YANG J, JIN X, et al. Based on Delphi method and analytic hierarchy process to construct the evaluation index system of nursing simulation teaching quality [J]. Nurse Educ Today, 2019, 79: 67-73. DOI: 10.1016/j.nedt.2018.09.021.

[16] ALBARQOUNI L, HOFFMANN T, STRAUS S, et al. Core competencies in evidence-based practice for health professionals: consensus statement based on a systematic review and Delphi survey [J]. JAMA Netw Open, 2018, 1(2): e180281. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2018.0281.

[17] 孙晓娥. 扎根理论在深度访谈研究中的实例探析[J]. 西安交通大学学报(社会科学版)，2011，31(6)：87-92. DOI：10.15896/j.xjtuskxb.2011.06.014.

[18] 国务院联防联控机制综合组. 关于加强基层医疗卫生机构发热诊室设置的通知[A/OL]. (2020-12-02)[2021-06-10]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/08/content_5568390.htm.

[19] 朱晓燕，杨永华，黄贇聪，等. 上海市发热哨点诊室与新加坡公共卫生防范诊所模式对比研究[J]. 中国全科医学，2021，24(34)：4306-4311. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.283.

（收稿日期：2022-02-14；修回日期：2022-06-27）
（本文编辑：陈俊杉）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net